



3

OBESIDAD

// DRA. AMAL SILVINA HASSAN*

Médica Pediatra Especialista en Nutrición.

Jefa de Sección de Nutrición Clínica del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti,
Mendoza.

Secretaria Comité de Nutrición, Sociedad Argentina de Pediatría.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar



PEDRO, 6 AÑOS

Pedro es su paciente desde el nacimiento. Asiste a control de salud, para elaborar el certificado para escuela. Su mamá refiere que como es un niño sano, no lo ha llevado a control en el último año.

Al examen físico nota a un niño sonriente y locuaz, colabora con el examen físico, toma peso y talla, con los siguientes valores: Peso 30 kg (z score +2,68), Talla 1,25 m (z score +1,84), IMC 21,7 (z score+2,34).

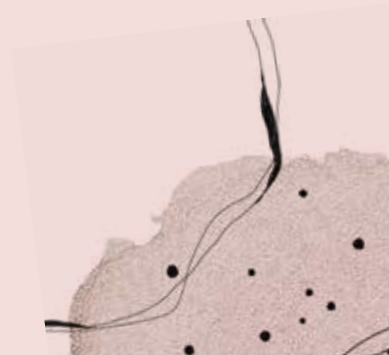
a) **¿Qué diagnóstico tiene por IMC?**

b) **¿Cómo completa la Historia Clínica? Mencione datos del interrogatorio que cree oportuno consultar.**

c) **¿Cómo plantearía el diagnóstico?**

d) **¿Qué acciones o indicaciones da?**

**Después de finalizar la lectura del capítulo,
compare sus respuestas con las que figuran en Clave de Respuestas.**

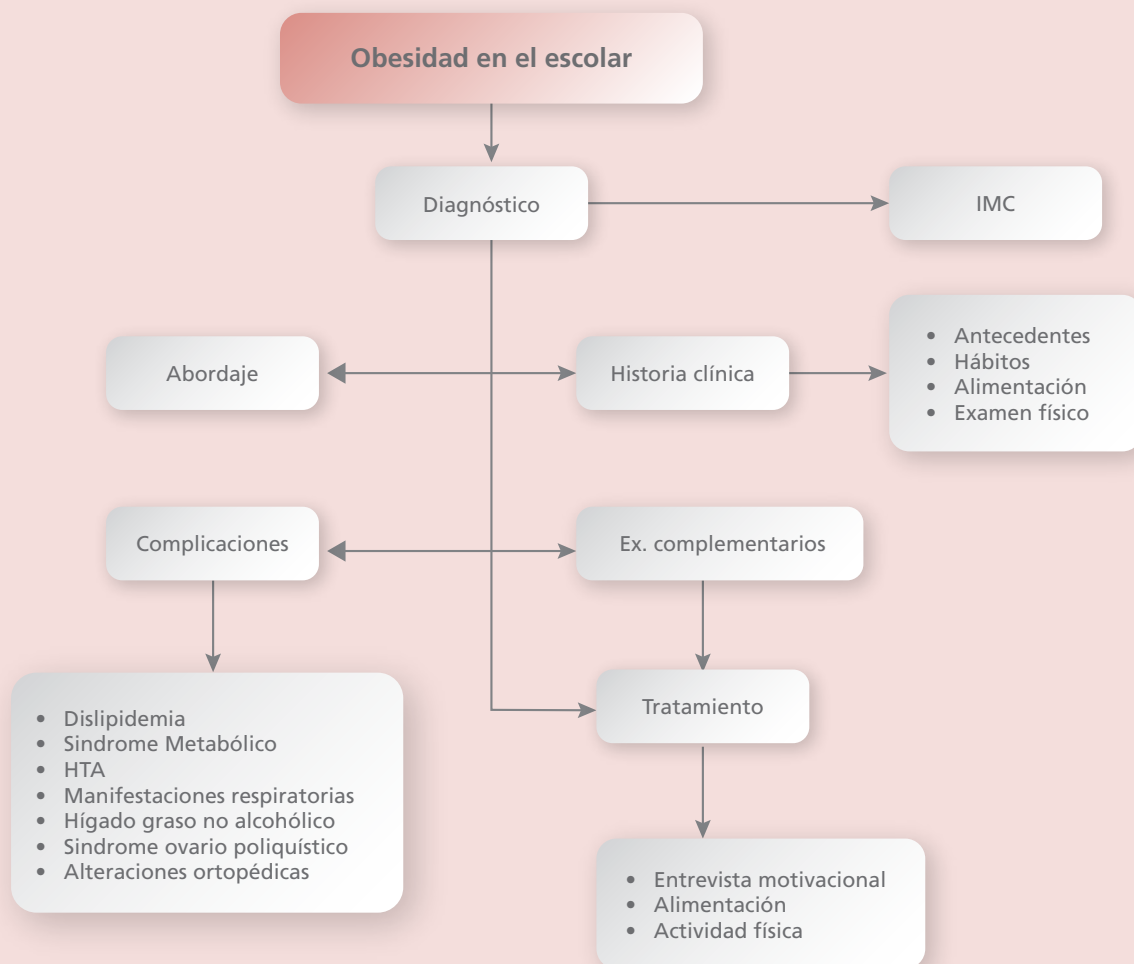


OBJETIVOS

- ◆ Diagnosticar sobrepeso u obesidad utilizando el índice de masa corporal (IMC).
- ◆ Realizar una historia clínica dirigida a investigar aquellos datos que suponen riesgo de desarrollo de la enfermedad.
- ◆ Identificar factores que aumentan el riesgo de padecer sobrepeso, obesidad y mayor morbimortalidad
- ◆ Indagar sobre los hábitos (alimentación, actividad física, sueño, sedentarismo, uso de pantallas) asociados al sobrepeso y la obesidad
- ◆ Ofrecer al paciente y su familia estrategias de control para lograr un estilo de vida saludable con adecuados hábitos de alimentación y actividad, que involucren al paciente y su familia.
- ◆ Fortalecer el vínculo de relación médico paciente para permitir el seguimiento.



ESQUEMA DE CONTENIDOS



INTRODUCCIÓN

Millones de niños y adolescentes (NNyA) en el mundo padecen obesidad, es considerada una de las enfermedades crónicas más comunes. Históricamente ha sido estigmatizada como consecuencia de elecciones personales, hoy se sabe se debe a un complejo juego de factores genéticos, psicológicos, socioeconómicos y del medio.

Ante la influencia de un medio obesogénico creciente, se considera crucial proveer al médico pediatra de conocimiento y habilidades para el manejo de la obesidad en esta población.

Según las estadísticas de Organización Mundial de la Salud, en 2.022 más de 390 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años tenían sobrepeso (SP), entre ellos 160 millones con obesidad (O). La prevalencia de sobrepeso y obesidad ha aumentado drásticamente, pasando del 8% en 1990 al 20% en 2022.

En **Argentina**, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNYS 2°) - 2019 encuentra una prevalencia de SP del 20,7% y de O del 20,4% en el mismo grupo etario.

La obesidad es una enfermedad de larga duración, persistente, que trae efectos negativos en la salud, morbilidad e incremento de mortalidad, con impacto económico, social, pero sobre todo generando deterioro en la calidad de vida.

Considerando la trascendencia de la enfermedad, el diagnóstico debe ser precoz y el tratamiento debe comenzar lo más rápido posible, por lo tanto, se revaloriza la función del médico pediatra en esta tarea, para prevenir, detectar, intervenir, derivar oportunamente, sin perder el contacto con el paciente y su familia.

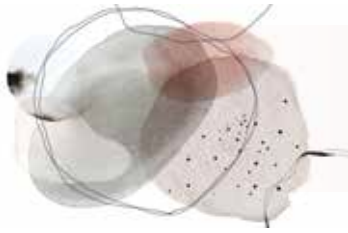
La prevención y manejo de la obesidad requieren esfuerzos de varios “actores”, la familia, la escuela, el barrio, la publicidad. El abordaje debe conducir a lograr un estilo de vida saludable con adecuados hábitos de alimentación y actividad, que involucren al paciente y su familia.

Este capítulo propone ofrecer al pediatra herramientas para detectar en la consulta periódica o de urgencia la enfermedad, y luego determinar situación de riesgo asociado al sobrepeso u obesidad, poder ofrecer estrategias de control, seguimiento del paciente o bien, la derivación oportuna.

DIAGNÓSTICO

Se define sobrepeso y obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa que representa un riesgo para la salud.

El empleo del Índice de Masa Corporal (IMC) es útil como herramienta diagnóstica, permite determinar el punto de corte y así diagnosticar la enfermedad, y de acuerdo al valor o desvío desde la media, la dimensión o gravedad de obesidad, a mayor desvío mayor grado de obesidad, que supone mayor riesgo de morbimortalidad.



El IMC permite diagnóstico, seguimiento y se correlaciona con los parámetros de la etapa adulta.

Tabla 1. Diagnóstico según la Organización Mundial de la Salud (OMS) para NNyA de 5 a 19 años

	SOBREPESO	OBESIDAD
Percentilo	85 a 97	Mayor a 97
Desvíos standard (puntaje z)	Entre + 1 y + 2 DS	Mayor de + 2 DS

Obesidad Severa: IMC mayor a 3 DS

Es importante el seguimiento en el tiempo con las curvas de IMC, su “trayectoria” es útil para determinar el momento de aparición de SP u O y su evolución.

Relación con el momento de rebote adipositario; la obesidad que aparece antes del rebote adiposo (normal entre 5 y 6 años), prevé mayor riesgo de obesidad en edad adulta.

ABORDAJE

La consulta de un paciente portador de sobrepeso y obesidad puede surgir de diferentes maneras, y es oportuno “imaginar” estrategias para su manejo:

- El sobrepeso y la obesidad son el motivo de consulta.
- Asiste a control periódico de salud.
- Conoce la situación, pero no la menciona, el pudor o vergüenza impiden mencionar la situación.
- Reconoce la situación y se siente frustrado, puede referir tratamientos previos, su éxito o fracaso.
- Surge luego de un evento de discriminación.
- La familia toma actitud de reproche hacia el niño por no adherir a cambios.
- Refiere que otros miembros de la familia padecen la obesidad y teme por el niño.

O bien, no hay registro de los cambios o de la obesidad del paciente y/o su familia, en este caso se propone realizar preguntas: ¿Qué les preocupa? ¿Han notado cambios en su crecimiento?

ELABORACIÓN DE HISTORIA CLÍNICA

Antecedentes

Los antecedentes colaboran en completar el conocimiento del paciente, evaluar riesgos actuales y futuros, aportan datos para planificar el abordaje.

Se propone realizar una historia clínica dirigida a investigar aquellos datos que suponen riesgo de desarrollo de la enfermedad.

Tabla 2. Factores que aumentan el riesgo de padecer sobrepeso, obesidad y mayor morbilidad

Etapas Prenatal	Sobrepeso materno o alta ganancia de peso durante la gestación y diabetes gestacional.
Nacimiento	Bajo o alto peso para edad gestacional (< 2500 g o > 4000 g).
Etapas Postnatal	Rápida recuperación de peso en etapa inicial para aquellos recién nacidos de bajo peso para la edad gestacional.
Lactancia materna	Protege de la O por una regulación más fisiológica de la ingesta y favorecer un microbiota saludable, su ausencia o duración < 6 meses es factor de riesgo para O.
Momento de aparición de Obesidad	Aparición temprana, sobre todo antes de los 2 años (descartar causas genéticas) o antes del rebote adiposo.
Historia familiar	Antecedentes de O en uno de los padres aumenta el riesgo de 2-3 veces y en ambos 15 veces, sobre todo si es materna.
Experiencias adversas	Historia de abuso psicológico, físico o sexual, violencia, mudanzas, cirugías.
Empleo de fármacos	Glucocorticoides, antidepresivos (amitriptilina, paroxetina, sertralina), antiepilépticos (carbamazepina, gabapentina, pregabalina, valproato, vigabatrina), antipsicóticos (aripiprazol, haloperidol, olanzapina, quetiapina, risperidona).
Condición clínica	La presencia de enfermedades endócrinas (enfermedad de Cushing), enfermedades asociadas a baja talla e IMC elevado (Pseudohipoparatiroidismo, Déficit de Hormona de Crecimiento, Hipotiroidismo, Mielomeningocele).
Discapacidad	Mayor riesgo de padecer obesidad (27-49% respecto de la población sin esta condición), los factores involucrados pueden ser: • Dificultad para sostener lactancia materna. • Disrupción en la regulación de apetito. • Fármacos que promueven ganancia de peso. • Selectividad alimentaria. • Hipersensibilidad sensorial. • Trastornos de conducta. • Limitación para realizar actividad física o falta de adaptación para posibilitar la realización de ejercicio o deporte.
Trastornos de espectro autista	Tienen riesgo incrementado de obesidad hasta 43%. Los factores involucrados pueden ser asociación a síndrome genético, los factores prenatales ya mencionados, empleo de fármacos, trastornos de conducta.
Déficit de Atención/ Hiperactividad	Presentan hasta 40% de mayor riesgo, probablemente asociado a impulsividad en modalidad de ingesta, a empleo de fármacos, a dificultades para adherir a orden o planes, ingesta de comida no saludable.

Hábitos

Considerando la importancia de los hábitos de vida saludable, se investiga cómo es un día de nuestro paciente, focalizando en alimentación y actividad.

Alimentación. La consulta puede realizarse con las herramientas que sean familiares al pediatra:

- Orden de alimentación, número de comidas al día, si realiza desayuno, si saltea comidas.
- Comidas en familia, fuera del hogar, compra comida elaborada.
- Con quién come.

Puede preguntarse: ¿Qué comiste ayer? O solicitarle escriba 3 días de alimentos (Registro alimentario).

Muchos pacientes saben de alimentos saludables, y suelen omitir datos al responder, o bien, al no conocer, les falta precisión en el relato, por lo cual puede conducirse sus respuestas.

Consultar por grupos de alimentos: frutas, verduras, lácteos, carnes, legumbres, cereales, si los reconoce, le gustan, los consume diariamente, cuánto de cada uno, si están disponibles en casa.

En este punto, podremos diferenciar los hábitos de la familia, y si dispone de los mismos: ¿Quién cocina en casa? ¿Qué come en la escuela?, ¿Lleva merienda o la compra? ¿Come en un solo recreo o en todos? Cómo se hidrata: ¿Qué toma? ¿Cuánto toma?

Hábitos de riesgo para sobrepeso y obesidad

- ✓ Saltear comidas, sobre todo el desayuno.
- ✓ Comer con frecuencia, hábito de picoteo, "robar" comida a deshoras.
- ✓ Comer solos, no sentarse a comer.
- ✓ Comidas fuera del hogar, take away o delivery.
- ✓ Consumo de jugos y gaseosas.
- ✓ Azúcar agregada.
- ✓ Alimentos ultraprocesados.

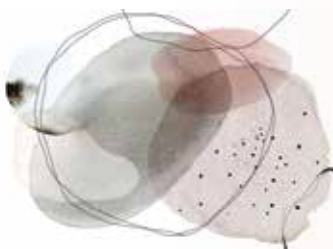
Ultraprocesados. Según la clasificación NOVA son formulaciones industriales principalmente a base de sustancias extraídas o derivadas de alimentos. Se incluyen entre ellos las bebidas gaseosas y otros jugos y bebidas azucaradas, los snacks dulces y salados, los caramelos (dulces), los panes industriales, las tortas y galletas (bizcochos), los cereales endulzados para el desayuno, los productos cárnicos reconstituidos y los platos previamente preparados. Son altamente adictivos y con gran fuerza de promoción para su venta. Su consumo es considerado potenciador del incremento de la obesidad en el mundo

Sueño: mayor riesgo de sobrepeso y obesidad con sueño entrecortado o menor a 10 h al día.

Uso de pantallas: sigue asociándose mayor riesgo con empleo mayor a 2 h al día.

Actitud sedentaria: sobre todo asociada al uso de pantallas.

Actividad Física: preguntar si ayuda en casa, camina hacia la escuela, juego individual, con amigos, usa bicicleta o patines, o práctica de deporte.



El realizar esta historia clínica dirigida, puede dar habilidades al pediatra para analizar, intervenir, orientar considerando el trascendente rol en el seguimiento de sus pacientes.

Examen físico

	Hallazgo	Posible asociación
Antropometría	Peso – Talla – Determinación de Índice de Masa Corporal (curvas) – Perímetro de Cintura. Edad de Comienzo y trayectoria. Comienzo temprano. Talla Baja.	Diagnóstico de enfermedad y su severidad. Obesidad Central. Obesidad de causa Genética o sobrealimentación. Asociación a síndromes.
Piel	Acantosis nigricans (engrosamiento y oscurecimiento de piel en axilas, pliegues, cuellos. Acné excesivo e hirsutismo. Micosis o irritación en pliegues. Forunculosis, hidradenitis supurativa. Estrías. Estrías violáceas. Xantomas cutáneos, en tendones, codos o rodillas. Xantelasmas en los párpados.	Insulinorresistencia. Síndrome de ovario poliquístico. Por excesiva Obesidad e higiene inadecuada. Cambios bruscos de peso. Síndrome de Cushing. Dislipidemias.
Cabeza y cuello	Ojos: Edema de papila, dolor retroocular, pérdida de la visión. Hipertrofia amigdalina. Bocio.	Pseudotumor Cerebral. Síndrome de Apneas obstructivas de Sueño. Enfermedad Tiroidea.
Tórax	Ginecomastia. Pseudoginecomastia en varones. Aumento de diámetro anteroposterior. Sibilancias. Intolerancia al ejercicio.	Efecto de hormonas femeninas. Asma Bronquial.
Determinación de signos vitales	Hipertensión Arterial.	< 16 años HTA: $\geq$ Pc 95. > 16 años HTA: sistólica $\geq$ 140 mmHg y/o diastólica $\geq$ 90 mmHg.
Abdomen	Distensión. Hepatomegalia – “sensibilidad” en hipocondrio derecho.	Constipación – Aumento de grasa abdominal. Litiasis Biliar. Enfermedad Hepática NO Alcohólica.
Osteoarticular	Marcha anormal, movimiento limitado de la cadera. Incurvación de las tibias. Dolor en pies. Dolores imprecisos: rodilla, cadera, pies. Manos y pies pequeños y polidactilia.	Epifisiólisis de la cabeza femoral. Enfermedad de Blount. Pie plano. Consecuencia de sobrepeso. Descartar síndromes genéticos.
Estadios de tanner	Desarrollo puberal precoz. Pseudomicropene. Testículos no descendidos.	Varones < 9 años y mujeres < 8 años por excesiva cantidad de grasa en región púbica. Síndrome de Prader Willi.

Fuente: Guías de práctica clínica para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la obesidad. Actualización 2024. Arch Argent Pediatr.

Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Treatment of Children and Adolescents with Obesity. PEDIATRICS Volume 151, number 2, February 2023.

COMPLICACIONES /COMORBILIDADES

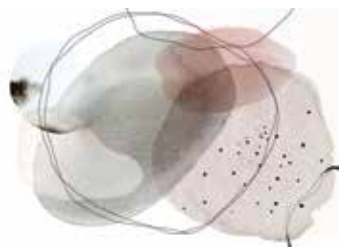
Tabla 3. Principales complicaciones / comorbilidades	
Metabólicas	Dislipidemias. Síndrome Metabólico. Diabetes Mellitus Tipo 2.
Cardiovasculares	Hipertensión Arterial. Aumento de Riesgo cardiovasculares.
Respiratorias	Síndrome de Apneas Obstructivas del Sueño. Asma Bronquial. Bajo Fitness Respiratorio.
Ortopédicas	Pie plano. Dolor Osteoarticular. Epifisiolisis de Cadera. Tibia Vara.
Hepáticas	Litiasis Biliar. Enfermedad Hepática No Alcohólica.
Renales	Glomeruloesclerosis.
Salud Mental	Baja Autoestima. Depresión.
Endócrinas	Pseudoginecomastia. Síndrome de Ovario Poliquístico.
Neurológicas	Pseudotumor Cerebral.

Los niños con obesidad tienen incremento en la prevalencia de comorbilidades y mayor riesgo de obesidad en la etapa adulta, así como morbilidad y muerte prematura.

Las complicaciones más frecuentes son:

- Dislipidemia.
- Síndrome Metabólico.
- Hipertensión Arterial.
- Hígado Graso NO Alcohólico.
- Síndrome de Apneas Obstructivas de Sueño.

Dislipidemia



Los niños con sobrepeso y obesidad tienen 3 veces mayor posibilidad de perfil lipídico alterado que los pacientes con IMC normal.

El patrón típico es:

- Elevación de triglicéridos.
- Descenso de HDL, colesterol (sostenidos por la insulinoresistencia).
- Colesterol total y LDL colesterol elevados.

Tabla 4. Tamizaje universal de dislipidemias. Recomendaciones por edad

Edad (en años)	Recomendación
De 0 a 2	No dosar de rutina.
De 2 a 6	NO dosar excepto: Abuelos, padres, tíos o hermanos (hombres < 65 años -mujeres 55 años) con Infarto Agudo de Miocardio, Accidente Cerebrovascular, Colocación de Stent, angioplastia o padres con Colesterol Total $\geq$ 240 mg% o dislipidemia conocida. Niños con diabetes, hipertensión arterial, obesidad.
De 6 a 11	TAMIZAJE UNIVERSAL
De 12 a 16	NO dosar excepto: Abuelos, padres, tíos o hermanos (hombres < 65 años -mujeres 55 años) con Infarto Agudo de Miocardio, Accidente Cerebrovascular, Colocación de Stent, angioplastia o padres con Colesterol Total $\geq$ 240 mg% o Dislipidemia conocida. Niños con diabetes, hipertensión arterial, obesidad, fumadores. Niños con enfermedad renal crónica, enfermedad de Kawasaki con aneurismas coronarios, Síndrome nefrótico, trasplante cardíaco, VIH-SIDA.
De 17 a 21	TAMIZAJE UNIVERSAL

Tabla 5. Valores de Referencia de lípidos y lipoproteínas

Parámetro	Aceptable mg/dl	Límite mg/dl	Elevado mg/dl
Triglicéridos 0-9 años 10-19 años	< 75 < 90	75 - 99 90 - 129	$\geq$ 100 $\geq$ 130
Colesterol Total	> 170	170 - 199	$\geq$ 200
LDL c	< 110	110 -130	$\geq$ 130
HDL c	> 45	40 - 45	< 40

Al momento de evaluar la dislipidemia, recordar la recomendación de Consenso de Lípidos de SAP, la condición de obesidad hace al paciente candidato a la evaluación del perfil lipídico y no debe dejar de considerarse la posibilidad de Hipercolesterolemia Familiar Heterocigota, cuya prevalencia es de 1/300-500 individuos, por lo cual pueden superponerse ambas condiciones.

Síndrome metabólico

Es la suma de diversas anomalías metabólicas, cada una un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular y diabetes, juntas ejercen un efecto sinérgico sobre el riesgo.

La obesidad abdominal y la resistencia insulínica son los factores principales.

La Sociedad Argentina de Pediatría considera los criterios de Cook modificados, y **se diagnostica detectando 3 de los 5 criterios**.

Tabla 6. Criterios de Cook modificados		
Criterios	Cook (modificado) (10- 15 años)	IDF (mayores de 16 años)
Perímetro de Cintura (Obesidad Central)	≥ Percentilo 90	≥ Percentilo 90
Tensión Arterial	≥ Percentilo 90	TAS ≥ 130 mm Hg TAD ≥ 85 mm Hg
Triglicéridos	≥ 110 mg/dl	≥ 150 mg/dl
HDL colesterol	< 40 mg%	< 40 mg%
Glucemia	≥ 100 mg%	≥ 100 mg%

Fuente: Cuartas S. (2022) PRONAP Nutrición. Módulo 3.

Es importante rescatar datos de la Historia Clínica orientada a detectar el riesgo: historia familiar de Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2), enfermedad coronaria, obesidad, hipertensión arterial, diabetes gestacional materna, bajo o alto peso al nacer y excesiva ganancia de peso en el primer año, rebote adipocitario precoz, signos físicos de insulinoresistencia, sobre todo acantosis nigricans y tomar circunferencia de cintura para diagnosticar la obesidad central.

Hipertensión arterial

La prevalencia de hipertensión arterial en la obesidad es del 5-30%, y aumenta a mayor IMC. Algunos estudios muestran que la presencia de hipertensión aumenta el riesgo de padecerla en la etapa adulta y también el riesgo de enfermedad cardiovascular. Existe asociación con alteraciones de sueño, Síndrome de Apneas Obstructivas del Sueño e hipertensión arterial.

Es importante en la evaluación del paciente: controlar tensión arterial, determinar su percentilo y evaluar ingesta de sodio, como sal agregada en las comidas, tanto como en productos procesados, freezados y comidas rápidas, ya que su alto consumo está asociado a hipertensión en la Infancia.

Manifestaciones respiratorias

Favorecen a las manifestaciones respiratorias:

Condición anatómica. En el paciente con O, se observa compromiso de la vía aérea superior por la presencia de depósitos de grasa subcutánea e infiltración grasa de los músculos faríngeos, cuello más corto, laringe en una posición cefálica y lengua más voluminosa. propios de la edad pediátrica. La situación puede empeorar en caso de presentar hipertrofia amigdalina y adenoidea, lo cual puede generar obstrucción de vía aérea con riesgo de hipoventilación.

Condición fisiopatológica. Disminución de la compliance de la pared torácica por presencia de tejido graso, presencia de tórax “no acorde al volumen corporal” y menor excursión diafragmática por el volumen de la cavidad abdominal, condicionan aumento de trabajo ventilatorio.

Pueden presentar disnea de esfuerzo ante el ejercicio moderado, referido como bajo fitness respiratorio o baja tolerancia al ejercicio

Asma bronquial. Existe cierta relación con el asma bronquial: múltiples mecanismos involucrados que relacionan ambas enfermedades entre sí, aunque es difícil diferenciar qué ocurre primero.

Factores interrelacionados en obesidad y asma bronquial:

- Efectos sobre la mecánica pulmonar: a los antes mencionados puede sumarse el Re-flujo Gastroesofágico.
- Cambios en la respuesta inflamatoria e inmunológica: el incremento de la leptina e interleukinas proinflamatorias, en este “estado inflamatorio” de la obesidad, se alteran parámetros de función pulmonar.
- Activación de genes comunes (en ambas enfermedades).
- Influencia hormonal y sexo: más frecuente asma bronquial en mujeres, en edad puberal.

La obesidad, a través de mecanismos inflamatorios o cambios en el estilo de vida, puede favorecer el desarrollo de asma en personas susceptibles y el control de la obesidad mejora la evolución del asma y la respuesta al tratamiento

Síndrome Apneas Obstructivas del Sueño (SAOS). Se caracteriza por obstrucción parcial o completa de la vía aérea durante el sueño, con alteración de su patrón normal y de la ventilación. Se asocia con afectación neurocognitiva, de comportamiento, de sistema cardiovascular, alteraciones metabólicas y del crecimiento. Su prevalencia estimada en niños es 2-3% de la población. En adolescentes con obesidad, es de 13-66%.

Manifestaciones nocturnas: ronquido, respiración dificultosa, sueño inquieto o fraccionado, sudoración excesiva, terrores nocturnos, enuresis secundaria. Pausas respiratorias o respiración bucal.

Manifestaciones diurnas: voz nasal, rinorrea, infecciones respiratorias altas recurrentes, retrognatia y riesgo de cor pulmonale e hipertensión pulmonar.

Diagnóstico: a través de estudio polisomnográfico (PSG) con índice de apnea-hipopnea (IAH - número promedio de eventos respiratorios desordenados por hora).

Tabla 7. Clasificación de Gravedad según Índice Apnea-Hipopnea		
	ÍNDICE APNEA-HIPOPNEA	
	Niños	Adolescentes-adultos
Leve	< 5	5 - 10
Moderado	5 - 10	15 - 30
Grave	10	> 30

Hígado graso no alcohólico

El hígado graso no alcohólico (EHNA o NAFLD en inglés) es una enfermedad crónica hepática marcada por la infiltración grasa del hígado, en un espectro que va de la esteatosis (infiltración grasa), esteatohepatitis (con componente de inflamación) pudiendo llegar a la fibrosis y cirrosis hepática.

Es la causa más común de enfermedad crónica hepática en la infancia, pudiendo llegar hasta el 34% en los niños obesos.

Fuertemente asociada a obesidad (sobre todo central), insulinoresistencia, hipertensión, dislipidemias y DMT 2, se considera la manifestación hepática del Síndrome Metabólico.

Su presencia aumenta el riesgo cardiovascular del paciente.

Mayor riesgo de padecer EHNA	Mayores de 10 años. Entre 2 a 9 años en casos de obesidad severa. Hermano con EHNA (genética). Diabetes Mellitus 2, dislipidemia, síndrome metabólico, SAOS.
Diagnóstico	Sospecha clínica (antecedentes). Sospecha de insulinoresistencia. Elevación de GPT (ALT) al doble de su valor normal, ligera y sostenida al menos 3 meses (principal marcador de la enfermedad). Ecografía Abdominal: no invasivo, aunque de baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Biopsia hepática: es el patrón de oro para confirmar esteatosis y determinar grado de inflamación y fibrosis (la decisión es resorte de gastroenterólogo).
Mayor riesgo de progresión	Mayor de 14 años. Mayor elevación de GPT (ALT), GOT (AST), GGT, LDL colesterol. Diabetes Mellitus Tipo 2, SAOS. Obesidad Central. Suma riesgo de otras comorbilidades y de muerte.

En general, es una enfermedad asintomática, se propone llegar al diagnóstico por sospecha clínica, por asociación con antecedentes familiares, condiciones adversas en embarazo, insulinoresistencia (acantosis nigricans) otras comorbilidades.

Síndrome de ovario poliquístico

Se trata de un desorden heterogéneo caracterizado por hiperandrogenismo y disfunción ovulatoria. Prevalencia entre 3 - 11%. Sospecha frente a signos clínicos de hiperandrogenismo: acné, hirsutismo, alopecia, vello pubiano de distribución masculina, signos de insulinoresistencia (acantosis nigricans) y alteración de ciclos menstruales luego de 2 años de la menarca.

Asociación con:

- ✓ Obesidad – Insulino resistencia - Síndrome Metabólico.
- ✓ Bajo peso de nacimiento.
- ✓ Heredabilidad: junto con obesidad, insulinoresistencia, DBT 2, síndrome metabólico.
- ✓ La condición aumenta el riesgo de infertilidad, Diabetes Mellitus tipo 2, enfermedad cardiovascular y cáncer.

Diagnóstico por Criterios de Rotterdam 2003: presencia de al menos dos de los siguientes criterios:

- ✓ Oligo y/o anovulación (ej. ≤ 8 períodos menstruales en el año de más de 35 días de duración).
- ✓ Hiperandrogenismo (i.e. acné) y/o hiperandrogenismo bioquímico: i.e. testosterona total (TT) ≥ 2.6 nmol/l, testosterona libre (FT) ≥ 6.0 pg/ml, DHEAS.
- ✓ Ovario Poliquístico (presencia de ≥ 12 folículos en cada ovario $> 2-9$ mm de diámetro).
- ✓ Luego de exclusión de otras etiologías: hiperplasia adrenal congénita, tumores androgensecretores y Síndrome de Cushing.

Diagnóstico:

- ✓ Sospecha por antecedentes y clínica.
- ✓ Dosaje de Testosterona Total y libre, DHEA.
- ✓ ecografía ginecológica.

Derivación a Ginecólogo Infantojuvenil.

Alteraciones ortopédicas

Epifisiolisis de cabeza femoral. Es la manifestación más frecuente de cadera en la adolescencia.

Entre 9 y 16 años, durante el período de rápido crecimiento, más frecuente en varones y de lado izquierdo (aunque 25% es bilateral).

Sospecha clínica: reinguera inexplicable y dolor en zona anteromedial del muslo y rodilla (o dolor de rodilla y /o cadera), dolor constante o frente a cargas, afección uni o bilateral.

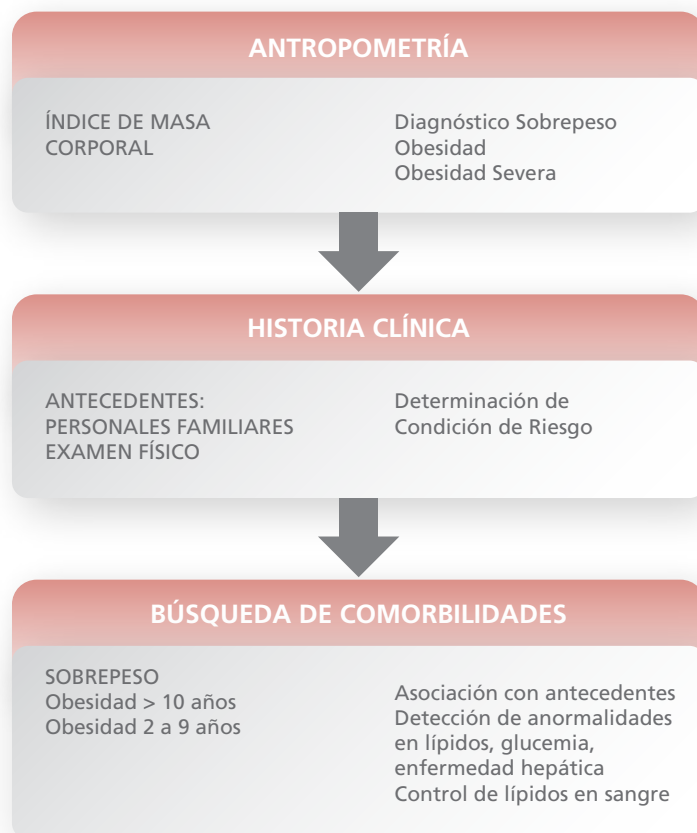
Renguera: antiálgica (por dolor), da paso corto del lado involucrado y largo del contralateral - Hábito físico: “adolescente con obesidad tipo adiposogenital” o con genitales subdesarrollados. El miembro afectado se mantiene en rotación lateral, con restricción del movimiento que depende de la severidad. Ante progresión se tiene mayor riesgo de necrosis avascular de cabeza femoral.

Diagnóstico: radiografía de cadera y derivación a traumatólogo.

Enfermedad de Blount. Tríada de tibia vara, torsión de tibia y precurvatum. El factor de riesgo es exceso de peso, que genera stress mecánico sobre la fisis. Dolor en miembros inferiores, alteración de la marcha, incurvación de miembros inferiores y discrepancia en la longitud de los mismos. La manifestación de la enfermedad que ocurre luego de los 10 años, en general, es la que se asocia a la obesidad.

Diagnóstico: ambas enfermedades se diagnostican con radiografía simple y requieren derivación al traumatólogo.

Resumen



EXÁMENES COMPLEMENTARIOS A SOLICITAR

El objetivo es:

- ✓ Detectar comorbilidades.
- ✓ Considerar el riesgo de enfermedad cardiometabólica.
- ✓ Orientar a tratamiento.
- ✓ Motivar a la realización de tratamiento.
- ✓ Realizar seguimiento y evaluar tratamiento.

Laboratorio:

Pacientes con O. Evaluación de metabolismo de glucosa, perfil lipídico y disfunción hepática (en mayores de 10 años).

- ✓ Glucemia de ayuno.
- ✓ Perfil lipídico (Colesterol Total, LDL, HDL, Triglicéridos).
- ✓ Hepatograma (GOT, GPT, GGT): en mayores de 10 años, con riesgo de DMT 2 y NAFLD.

Pacientes con Sobrepeso: la determinación de glucemia de ayuno y perfil lipídico pueden considerarse según la evolución de la enfermedad, antecedentes familiares, hábitos.

Para descartar riesgo de DMT 2 y NAFLD/EHNA, considerar el riesgo asociado a Sobrepeso (> 10 años).

Riesgo de Diabetes Mellitus Tipo 2

- ✓ Historia familiar.
- ✓ Historia de diabetes gestacional.
- ✓ Signos clínicos de insulino resistencia (acantosis nigricans).
- ✓ Uso de medicación obesogénica.

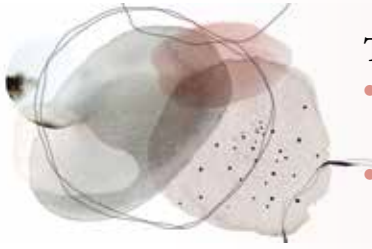
El diagnóstico de DMT 2 se basa en:

- Glucemia en ayunas.
- Prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTO) o hemoglobina A1c.

Estas pruebas **no se recomiendan en la práctica habitual**, se recomienda su derivación a especialista en nutrición o endocrinología pediátrica.

Riesgo de EHNA (NAFLD)

- ✓ Historia familiar de EHNA.
- ✓ Obesidad Central.
- ✓ Signos de Insulinoresistencia, prediabetes o diabetes.
- ✓ Dislipidemia.
- ✓ Apnea del sueño.



Tener en cuenta:

- Exámenes normales no descartan el diagnóstico inicial de sobrepeso y obesidad.
- En casos de obesidad severa, no se considera edad para solicitar estudios.
- En cada comorbilidad se han mencionado otros estudios: ecografía abdominal, polisomnografía, dosaje de testosterona, DHEA, ecografía ginecológica, radiografía simple.
- Considerar derivación frente a sospecha de DMT 2, EHNA, Síndrome de ovario poliquístico, epifisiolisis de cadera.

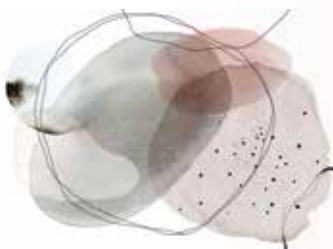
TRATAMIENTO

El tratamiento se propone como un modelo de abordaje de enfermedad crónica, considerando los factores individuales, el medio del paciente (familia, escuela), accesibilidad a alimentos y a espacios de actividad.

Como enfermedad crónica, puede evolucionar con “logros” y recaídas, que empeoran al dejar el tratamiento:

- Tratar la Obesidad lleva concurrentemente a prevenir, monitorizar y tratar las comorbilidades.
- Objetivos: lograr descenso de peso, evitar nueva ganancia de peso, prevenir o tratar comorbilidades.
- Para lograr estos objetivos, se debe lograr “alianza”, adherencia del paciente y su familia.
- Acompañamiento del paciente en su evolución desde la infancia, adolescencia y adultez, incorporando hábitos saludables para alcanzar el mejor estado de salud posible.
- INTERVENCIÓN EN ESTILO DE VIDA SALUDABLE.
- Cambios simultáneos de alimentación, actividad, estimulando la autoestima.

Acordar con el paciente y permitir tratar el tema del IMC o la obesidad



Preferir los términos “niño o paciente con obesidad” en lugar de “niño o paciente obeso”, utilizar expresiones neutras, “peso no saludable”, “ha ganado mucho peso para su edad”, y evitar “obeso”, “obeso mórbido”, “gordo”, “gordito”, “rellenito”.

Se propone abordaje de equipos con roles precisos, aunque se considera no todos los pacientes o pediatras tienen acceso a tales equipos, por lo cual, este documento analiza estrategias que

puedan abordarse desde el consultorio. Los equipos pueden contar con: médico pediatra, nutricionista, psicólogo, kinesiólogo, profesor de educación física, trabajador social en coordinación con familia, escuela, comunidad.

La motivación es el principal factor para lograr un cambio conductual. La entrevista motivacional es un método centrado en el paciente para incentivar al cambio que promueve conductas saludables, favorece sentimientos positivos en los pacientes y sus familiares y mejora los resultados clínicos.

Entrevista motivacional

De acuerdo con la teoría cognitivo-conductual, es un modelo de abordaje que busca llevar al paciente a hacerse responsable de los cambios, es un método centrado en el paciente con el objetivo de incentivar sus propias motivaciones al cambio (o la de los familiares en el caso de niños pequeños) y plantear sus objetivos.

Etapas del cambio: se consideran las etapas de cambio de Prochaska.

- Etapa 1: precontemplativo, el paciente aún no está considerando realizar un cambio.
- Etapa 2: contemplativo, el paciente está evaluando las razones a favor y en contra de realizar un determinado cambio.
- Etapa 3: preparación, lo está planificando.
- Etapa 4: acción, se realizó un cambio hace menos de 6 meses.
- Etapa 5: mantenimiento, el paciente mantiene el cambio por más de 6 meses.

Se sugiere	Herramientas
• Evitar discutir o tratar de persuadir al paciente para realizar un cambio. • Entender la motivación del paciente • Escuchar al paciente. • Darle poder y confianza. • Acordar pequeños objetivos para incrementar la sensación de éxito.	• Formular preguntas indirectas que evalúen la preocupación. • Escuchar reflexivamente sin juzgar. • Implementar escalas de importancia y confianza. • Ayudar a los pacientes/padres a encontrar soluciones. • Involucrar a la familia en la fijación de objetivos posibles. • Reconocer los esfuerzos del paciente para bajar de peso. • Considerar los pros y los contras del cambio. • Finalizar la entrevista con un resumen para que el paciente vuelva a escuchar sus propias palabras.

Se intenta no dar planes rígidos, estáticos sino flexibilizar al estado en el que se encuentra el paciente. Es útil, buscar otras motivaciones que no estén relacionadas con el peso, acompañar, colaborar a buscar las estrategias posibles para el paciente, actitud refuerza el poder del paciente sobre sus decisiones y lo hace protagonista del cambio.

Planificar objetivos posibles. Aclarar que la función del pediatra es guiarlos en este proceso de cambio. Por ejemplo:

Paciente: “Este mes me propongo tomar los 8 vasos de agua”.

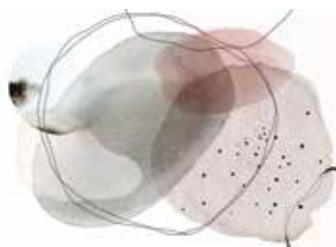
Profesional: “Excelente y crees poder mantenerlo este mes” y ¿qué otro cambio podrías sumar?”.

Paciente: “voy a llevarme fruta a la escuela además de mi botella de agua”.

La Academia Americana de Pediatría propone un modelo de Tratamiento intensivo de comportamiento y estilo de vida saludable-IHBLT (Intensive Health Behavior and Lifestyle Treatment), como un abordaje intensivo, para lograr reducción de Índice de Masa Corporal o atenuar la ganancia excesiva de peso, ofreciendo controles frecuentes e intensivos, para lograr alimentación saludable, de forma sostenida junto con hábitos de actividad física.

Incluye la participación de equipos multidisciplinarios, con intervención, individual, grupal, al paciente y su familia, con entrevistas presenciales y/o virtuales, entre 3 y 12 meses de intervención.

Cuando estos “sistemas” no están disponibles, se fortalece la función del pediatra, en la tarea.



Se desaconseja la prescripción de un plan “universal”, estructurado, se propone marcar metas pequeñas, que puedan lograrse y comprobarlo en las consultas.

Alimentación

Se proponen algunas estrategias para incorporar, con los recursos disponibles en cada sitio:

- ✓ Estimular el consumo de agua: conocer los requerimientos de líquidos y priorizar el agua.
- ✓ Reducción de consumos de bebidas azucaradas, golosinas y azúcar agregada: reconocer que bebidas gaseosas, jugos comerciales, bebidas deportivas tienen azúcar en su composición.
- ✓ Conocer grupos de alimentos y tamaños de porciones y recomendación de raciones diarias según edad.
- ✓ Conocer la “disposición” de un plato saludable, en donde se mencionan las proporciones de verduras, carnes, legumbres, pastas o farináceos. (ver imagen de GAPA).
- ✓ Incorporar diariamente frutas y verduras (“5 al día”).
- ✓ Preferir alimentos caseros (“hechos en casa”).
- ✓ Organizar comidas al día y evitar saltar el desayuno.
- ✓ Apoyado con recursos de entrevista motivacional, considerar en conjunto cambios posibles, armar la “estrategia”, evaluar en las siguientes consultas los logros.

Involucrar a la familia en el cambio, la “**familia como modelo**”

- **En casa:** Disponer alimentos saludables (frutas, verduras, agua) y controlar bebidas azucaradas, galletas rellenas, facturas, snacks.
- ✓ Planificar menú saludable y colaborar en el proceso de compra de alimentos.
- **En escuela:** conocer el menú escolar, adecuar las meriendas o viandas escolares, preparar en casa.

Imagen de las GAPA: Guías Alimentarias para la Población Argentina



Actividad física

Definido como “cualquier movimiento producido por músculos esqueléticos que requieren gasto energético”, juega un rol importante en la pérdida de peso al incrementar el gasto energético.

Según OMS, se considera a la actividad física (AF) beneficiosa porque mejora funciones cardiorespiratorias y musculares, la salud cardiometabólica (tensión arterial, dislipidemia, glucosa y resistencia a la insulina), la salud ósea, los resultados cognitivos (desempeño académico y función ejecutiva) y la salud mental (menor presencia de síntomas de depresión) y menor adiposidad.

Los beneficios de la AF se logran cuando se realiza como ejercicio físico (EF) de forma planeada, estructurada, repetitiva, con objetivos determinados y con intensidades de moderada a vigorosa, lo que genera que el músculo libere mioquinas.

Las mioquinas serían responsables de múltiples acciones con efectos antiinflamatorios, aumento de la insulinosensibilidad y mejoría del tejido adiposo blanco, al estimular la génesis de mitocondrias en él, aumentando así el gasto metabólico basal, **beneficio no provisto por ningún alimento ni fármaco**.

Recomendaciones de OMS (Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios. 2020), para NNyA de 5 a 17 años.

- ✓ Se recomienda realizar al menos una media de 60 minutos de actividad física diaria principalmente aeróbica de intensidad moderada a vigorosa.

- ✓ Al menos 3 días por semana deberían incorporar actividades aeróbicas de intensidad vigorosa, que refuercen músculos y huesos.
- ✓ Los niños y adolescentes deben limitar el tiempo que dedican a actividades sedentarias, especialmente el tiempo de ocio que pasan delante de una pantalla.

Los programas deben estimular al paciente a alcanzar los niveles recomendados de actividad física, en sus formas organizada y no organizada.

Los NNA con obesidad tienen menor coordinación, equilibrio, velocidad, agilidad y habilidades motoras finas y gruesas, en comparación con sus pares con peso normal, lo cual obstaculiza la adherencia a lograr los objetivos, entrando en un círculo vicioso de inactividad y ganancia de peso, además de su exposición a bullying y afectación de autoestima y calidad de vida.

Los pacientes con obesidad e insulinoresistencia presentan “inflexibilidad metabólica” (incapacidad de utilizar diferentes sustratos para generar energía según la situación), condición que puede revertir el EF de intensidad moderada a vigorosa.

Considerando que suele ser dificultoso incrementar la actividad física y el ejercicio, se recomienda que pueda acompañar esta tarea un profesor de educación física.

Se sugiere:

- Evaluación inicial del nivel de inactividad física y sedentarismo, preferencias, condiciones socioeconómicas y posibilidades de la familia para acompañar al paciente.
- Planificación del tipo, frecuencia, volumen, intensidad y progresión del entrenamiento por profesor de educación física, quien pueda lograr planificación personalizada, para evitar lesiones físicas o presiones psicológicas que desencadenen frustración, rechazo y abandono del EF.
- El entrenamiento de fuerza mejora la salud cardiorrespiratoria y metabólica, debe formar parte como los ejercicios de resistencia aeróbica.
- ✓ Hacer algo de actividad física es mejor que permanecer totalmente inactivo.
- ✓ Los niños y adolescentes deben comenzar con pequeñas dosis de actividad física, para ir aumentando gradualmente su duración, frecuencia e intensidad.
- ✓ El objetivo es alcanzar las recomendaciones diarias de AF publicadas por la OMS y mantenerlas a lo largo del tiempo.

Fármacos

Se considera el **empleo de fármacos** en casos graves, en los que los cambios del estilo de vida no son suficientes para producir una pérdida de peso que impacte favorablemente sobre la calidad de vida y/o las comorbilidades. Es tarea del médico especialista en nutrición, quien considerará los riesgos y beneficios, su indicación y seguimiento.

Los fármacos aprobados son:

- Orlistat: inhibidor de la lipasa intestinal, que bloquea la absorción de grasas a nivel intestinal, para mayores de 12 años.
- Liraglutide: Agonista de receptor de Glucagon-like peptide-1, para mayores de 12-16 años.

Cirugía

Se dispone de **tratamiento quirúrgico**, en combinación de variables, de IMC y comorbilidades, para pacientes que en seguimiento adecuado por equipo especializado no logran el descenso de peso deseado. La decisión debe tomarla el especialista, en el contexto de equipo multidisciplinario de Cirugía Bariátrica.



Autoevaluación

I. Lea los siguientes enunciados e identifique si son verdaderos (V) o falsos (F).

	V	F
1. Entre 5 y 17 años, se considera obesidad cuando el IMC se encuentra por encima de +2 ds de la media.	☐	☐
2. El diagnóstico de obesidad severa se da con IMC más de 3 ds de la media.	☐	☐
3. En la obesidad infantil, el perímetro abdominal es un indicador útil de riesgo cardiovascular.	☐	☐
4. La acantosis nigricans (engrosamiento y oscurecimiento de pliegues, axilas, cuello) se encuentra fuertemente asociada a insulino-resistencia.	☐	☐
5. El patrón de dislipidemias más frecuentemente asociado a obesidad es: colesterol total elevado, HDLc elevado y triglicéridos normales.	☐	☐
6. La Enfermedad Hepática NO Alcohólica se sospecha mediante antecedentes, clínica y elevación de GPT.	☐	☐
7. El sedentarismo es considerado uno de los principales factores de riesgo modificables de la obesidad infantil.	☐	☐
8. Las recomendaciones de OMS sobre actividad física para NNyA entre 5 y 17 años dicen que deben realizar una media de 30 minutos diarios de actividad física de intensidad de moderada a vigorosa.	☐	☐
9. El consumo de bebidas azucaradas se relaciona directamente con mayor riesgo de obesidad infantil.	☐	☐
10. Se recomienda dar un plan estructurado de alimentación con menú fijo.	☐	☐

II. Mencione recomendaciones de alimentación para incorporar en la consulta con cualquier tipo de pacientes.

.....

.....

III. Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas.

PEDRO

Relea el caso de Pedro y responda nuevamente a las consignas.

a) ¿Qué diagnóstico tiene por antropometría?

.....

.....

b) ¿Cómo completa la Historia Clínica? Mencione datos del interrogatorio que cree oportuno consultar:

.....

.....

c) ¿Cómo plantearía el diagnóstico?

.....

.....

d) ¿Qué acciones o indicaciones da?

.....

.....

AMPARO, 10 AÑOS

Asiste por primera vez a su consultorio Amparo para control de salud. Al elaborar su historia clínica, surgen algunos datos del interrogatorio, fue RNT/BPEG (EG 38 semanas, con Peso de 2.100 g), su mamá había aumentado 25 k y sufrió hipertensión arterial durante el embarazo. Le han dicho que es gordita desde los 3 años, aunque ha ocurrido lo mismo con sus hermanos, su papá se ha sometido a Cirugía Bariátrica, usted confirma que desde esa edad ha permanecido por encima de percentilo 97 de IMC.

Va a escuela doble turno y lleva 2 meriendas para la mañana, porque no desayuna en casa (un paquete de galletas rellenas, un turrón y una medialuna), aunque algunos días compra un jugo en caja y un alfajor, lleva una botellita de agua, pero no la termina. Come el menú del comedor, allí le dan jugo, pero no le gusta cuando cocinan las verduras, prefiere repetir las pastas, o come un poquito más de pan. Cuando llega a casa, toma la merienda. hace las tareas y luego juega en su celular hasta la hora de la cena. En la escuela tiene 1 día por semana educación física y va a danza 2 veces por semana.

Peso: 62 kg (+3,18 ds), Talla 1,45m (+0,8 ds) IMC: 29,4(+3,10ds), su piel es blanca, pero tiene signos de acantosis nigricans en el cuello, confirma obesidad central por circunferencia de cintura. Tensión Arterial Normal. Le cuenta que ha ido a la nutricionista varias veces, pero hace más de un año que no la ve

a) ¿Qué datos del interrogatorio considera ofrecen riesgo de padecer obesidad y comorbilidades en Amparo?

.....

.....

b) ¿Qué diagnóstico Nutricional determina?

.....

.....

c) ¿Qué exámenes complementarios solicita? ¿qué complicaciones o comorbilidades busca?

.....

.....

d) Recibe glucemia 95 mg%, Colesterol Total 212 mg%, HDL 35 mg%, Triglicéridos 168 mg%,
¿Cuántos criterios encuentra diagnosticar para Síndrome Metabólico?

.....

.....

e) ¿Qué hábitos considera son desfavorables?

.....

.....

f) ¿Cómo abordaría el diagnóstico y un tratamiento?

.....

.....

CONCLUSIONES

Ante la alta y creciente prevalencia de obesidad, el pediatra tiene el desafío y la valiosa posibilidad de intervenir frente a la enfermedad, en la prevención apoyando los hábitos saludables, en la identificación de pacientes de riesgo, en la detección temprana frente a cambios en la evolución en parámetros antropométricos, en la posibilidad de detectar complicaciones y aun en la derivación oportuna a especialistas, poder acompañar al paciente y su familia en el camino de la recuperación.

Se revaloriza la tarea insustituible del pediatra en:

- Prevención: fortaleciendo hábitos saludables al niño y su familia.
- Detección temprana de cambios de carriles de curvas de peso e IMC.
- Fortalecer alianzas con el niño y familia.
- Intervención precoz.
- El seguimiento debe ser longitudinal al niño y su familia.
- Derivación oportuna frente a condiciones de riesgo.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Hampf, S et al. Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Treatment of Children and Adolescents With Obesity. PEDIATRICS Volume 151, number 2, 1-100, February 2023.
- De Grandis, S et al. Guías de práctica clínica para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la obesidad. Actualización 2024. Arch Argent Pediatr. 2024; e202410478.
- Setton, D, Sosa, P- Comité Nacional de Nutrición, Guías de práctica clínica para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la obesidad, Arch Argent Pediatr 2011;109(3):256-266.
- Manual de aplicación de las Guías Alimentarias para la Población Argentina, Ministerio de Salud Argentina, <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bancos/2020-08/guias-alimentarias-para-la-poblacion-argentina.pdf>

CLAVE DE RESPUESTAS

I. Lea los siguientes enunciados e identifique si son verdaderos (V) o falsos (F).

1. Verdadero.
2. Verdadero.
3. Verdadero.
4. Verdadero.
5. **Falso.** El patrón típico es: elevación de triglicéridos, descenso de HDL, colesterol (sostenidos por la insulinoresistencia). Colesterol total y LDL colesterol elevados.
6. Verdadero.
7. Verdadero.
8. **Falso.** Se recomienda al menos una media de 60 minutos de actividad física diaria principalmente aeróbica de intensidad moderada a vigorosa a lo largo de la semana. Al menos 3 días por semana deberían incorporar actividades aeróbicas de intensidad vigorosa, que refuercen músculos y huesos.
9. Verdadero.
10. **Falso.** Se intenta no dar planes rígidos, estáticos sino flexibilizar al estado en el que se encuentra el paciente. Es útil, buscar otras motivaciones que no estén relacionadas con el peso, acompañar, colaborar a buscar las estrategias posibles para el paciente, actitud refuerza el poder del paciente sobre sus decisiones y lo hace protagonista del cambio. Planificar objetivos posibles. Aclarar que la función del pediatra es guiarlos en este proceso de cambio.

II. Mencione recomendaciones de alimentación para incorporar en la consulta con cualquier tipo de pacientes.

Estimular el consumo de agua:

- ✓ Reducción de consumos de bebidas azucaradas y golosinas.
- ✓ Conocer grupos de alimentos y tamaños de porciones y recomendación de raciones diarias según edad.
- ✓ Conocer la “disposición” de un plato saludable, en donde se mencionan las proporciones de verduras, carnes, legumbres, pastas o farináceos. (ver imagen de GAPA).
- ✓ Incorporar diariamente frutas y verduras (“5 al día”).
- ✓ Preferir alimentos caseros (“hechos en casa”).
- ✓ Organizar comidas al día y evitar saltar el desayuno.
- ✓ Lograr que la familia se involucre, acompañe y sea modelo.

III. Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas.

PEDRO

- a) Obesidad

- b) Es importante preguntar si tiene alguna preocupación, si acaso la obesidad lo fuera, o no la menciona. Hábitos de alimentación, si come frutas, verduras, cuántas meriendas lleva a la escuela. ¿Cómo pasa su día, si juega, hace deportes, si emplea pantallas y cuánto tiempo?
- c) Es recomendable cuidar las expresiones, si bien es oportuno dar el diagnóstico, es trascendental generar alianza y confianza, para permitir continuar en su seguimiento.
Evitar las palabras "gordo", "gordito" y buscar estrategias posibles, mencionar su salud actual y futura, considerar si le parece puede realizar algún cambio.
- d) Por ejemplo, hemos detectado que has subido de peso, Crees/cree saber si ha habido algún cambio? Crees/cree que podrías hacer algo para mejorar tu/ salud? (si se siente cómodo hablar con el paciente, aunque se involucra a su familia).
¿Saben que la Actividad Física es saludable? Conociendo los beneficios del ejercicio, pensar en cuál actividad podría incorporar.
Si come pocas frutas y/o verduras, ¿crees/cree que puedas probar o incorporar alguna diariamente? ¿O bien aumentar el número que consumes?

AMPARO, 10 AÑOS

- a) Bajo Peso para la edad gestacional y más si ganó rápidamente peso, comienzo de obesidad antes de los 5 años, otros familiares con obesidad.
- b) Obesidad severa con talla normal.
- c) Glucemia, hepatograma, perfil lipídico. Debe descartar enfermedad hepática no alcohólica, descartar síndrome metabólico.
- d) Obesidad central, HDL < 40mg% y Triglicéridos > 110 mg%- 3 de 5 criterios, es diagnóstico de Síndrome Metabólico.
- e) No desayuna, consume ultraprocesados (jugo, alfajor, galletas), poco consumo de agua, aparentemente pocas frutas y verduras.
- f) Posibles estrategias: siempre focalizando en la salud. ¿Cómo ves tu peso? ¿Podrías mejorar algunas de tus costumbres? ¿Qué recordás haber hablado con la nutricionista? ¿Creés poder cambiar algo? Elijamos algunos aspectos, ejemplo: ¿podrías tomar más agua? ¿Recordás cuanto debes tomar en el día?

Actividad: lo ideal sería que todos los días hicieras actividad física, al menos 60 minutos. ¿Podríamos cambiar celular por algo de movimiento? ¿Qué podría ser? Dando posibilidad de que Amparo elija y si no, dar opciones, ¿Y si buscaras música en el celular e hicieras coreografías? ¿andar en bicicleta o jugar a la pelota?

Es muy importante el seguimiento de Amparo, volver a verla, para ver sus logros, armar nuevas estrategias.

